BONUS 01

GUIDA CLINICA ALLA PROGRESSIONE TERAPEUTICA

Come far progredire gli esercizi in modo sicuro, dalla consapevolezza all'integrazione funzionale

1. PRINCIPI DELLA PROGRESSIONE

Un programma di riabilitazione del pavimento pelvico è efficace quando il carico aumenta in modo graduale e misurabile. La progressione si basa sulla qualità del gesto: si avanza solo quando la paziente esegue correttamente l'esercizio, con una contrazione senza spinta verso il basso, un rilascio completo e una respirazione libera.

Ogni esercizio della raccolta riporta la voce Progressione: questa guida spiega quando applicarla e come costruire un percorso coerente nel tempo.

2. LE VARIABILI DA MODIFICARE

Variabile	Come progredire
Posizione	Supina o con bacino sollevato, poi quadrupedia, seduta, in ginocchio, in piedi, infine nei gesti funzionali.
Durata della tenuta	Da 3 a 5 secondi fino a 10 secondi, con un tempo di riposo almeno uguale alla tenuta.
Ripetizioni e serie	Da 5 a 8 ripetizioni fino a 10 o 12, poi 2 o 3 serie.
Velocità	Contrazioni lente prima, contrazioni rapide di un secondo poi, infine alternate.
Carico e attività	Peso del corpo, poi carichi leggeri, salita delle scale, sollevamenti, impatto.
Complessità	Esercizio isolato, poi combinato con movimento degli arti, doppio compito, attività quotidiane.

3. CRITERI PER AVANZARE

- La paziente percepisce e descrive la contrazione e il rilascio.
- La contrazione è corretta in almeno 8 ripetizioni consecutive.
- Il rilascio dopo ogni contrazione è completo.
- La respirazione resta libera, senza apnea o spinta addominale.
- Nessun aumento di dolore, perdite o sensazione di peso durante e dopo l'esercizio.
- Buona aderenza al programma domiciliare per almeno 2 settimane.

4. LE FASI DEL PROGRAMMA

Fase	Obiettivo	Esercizi tipici	Durata indicativa
1. Consapevolezza	Percepire contrazione e rilascio	Respirazione diaframmatica, identificazione del pavimento pelvico	1 o 2 settimane
2. Attivazione	Contrazione corretta e ripetibile	Contrazioni lente e rapide da supina e seduta	2 o 4 settimane
3. Rinforzo	Forza e resistenza	Tenute più lunghe, ponte, squat, posizioni verticali	4 o 8 settimane
4. Integrazione	Uso del pavimento pelvico nei gesti quotidiani	Precontrazione, sollevamenti, scale, cambi di posizione	4 settimane
5. Mantenimento	Conservare i risultati	Programma ridotto, 2 o 3 volte a settimana	A lungo termine

Le durate sono indicative e vanno adattate alla valutazione iniziale, al quadro clinico e alla risposta della paziente.

5. VALUTARE LA FORZA: SCALA DI OXFORD MODIFICATA

Grado	Descrizione
0	Nessuna contrazione percepibile.
1	Fremito o pulsazione appena percepibile.
2	Contrazione debole, senza sollevamento.
3	Contrazione moderata con lieve sollevamento.
4	Buona contrazione con sollevamento contro una leggera resistenza.
5	Contrazione forte con sollevamento contro una resistenza decisa.

6. RIFERIMENTO DI DOSAGGIO

Per l'incontinenza urinaria da sforzo e mista, le linee guida NICE (NG123) raccomandano un programma di allenamento del pavimento pelvico supervisionato di almeno 3 mesi, con almeno 8 contrazioni eseguite 3 volte al giorno. Usa questo riferimento come base minima e personalizzalo sulla valutazione.

7. PERCORSI PER QUADRO CLINICO

Quadro clinico	Priorità iniziale	Come progredire	Attenzione a
Gravidanza	Respirazione e rilascio	Mobilità del bacino, rinforzo leggero dei glutei	Supina prolungata dopo la 20ª settimana
Post partum	Respirazione e trasverso	Ponte, squat, gesti con il neonato	Diastasi, ferita del cesareo
Incontinenza urinaria	Contrazione corretta	Posizioni verticali, Knack, attività funzionali	Urgenza con segni di infezione
Dolore pelvico	Rilassamento e respiro	Mobilità e allungamenti	Evitare il rinforzo intenso
Ipertono	Rilascio e discriminazione	Allungamenti, poi contrazioni leggere	Dolore durante gli esercizi
Ipotono	Attivazione corretta	Tenute più lunghe e carico	Spinta verso il basso
Prolasso	Gestione della pressione	Posizioni con meno carico, poi verticali	Valsalva e sollevamenti
Disfunzioni sessuali	Consapevolezza e rilascio	Mobilità, poi contrazioni ritmiche	Dolore e aspetti emotivi

8. QUANDO REGREDIRE O SOSPENDERE

- Comparsa o aumento di dolore durante o dopo gli esercizi.
- Aumento delle perdite o della sensazione di peso pelvico.
- Contrazione che peggiora di qualità con la fatica.
- Apnea, spinta addominale o compensi con glutei e adduttori.

9. BANDIERE ROSSE: INVIARE AL MEDICO

- Sanguinamento vaginale anomalo o ematuria.
- Febbre, bruciore o dolore alla minzione.

- Dolore pelvico acuto o in peggioramento.
- Perdita di sensibilità perineale o alterazioni neurologiche.
- Massa palpabile o prolasso in rapido peggioramento.
- In gravidanza: perdite di sangue o di liquido, contrazioni regolari, riduzione dei movimenti fetali.

Nota: questa guida è uno strumento di supporto e non sostituisce il giudizio clinico del professionista.